规训与逃避：东亚临床工作者在职业崇高化与现实风险间的异化生存研究

作者： [MUMU]

单位： [东亚某不知名三甲医院]

摘要

目的

本文旨在探讨东亚医疗环境下，临床工作者如何在"救死扶伤"的职业崇高叙事与"自我保存"的现实生存法则之间进行心理调适。重点分析非执业场所急救行为回避（Bystander Apathy in Medical Professionals）的成因，以及这种"防御性冷漠"背后的社会制度逻辑。

方法

采用质性研究（Qualitative Research）与案例分析法。基于对东亚某大型三甲医院医护人员的深度访谈（N=30），结合贺银成高铁急救受罚等典型司法案例，运用社会交换理论（Social Exchange Theory）分析职业风险与回报的失衡机制。

结果

研究发现，现行法律对"医师执业地点"的刚性限制与社会对"白衣天使"的道德绑架形成了双重挤压。医护人员在经历了高强度的制度性过劳（Institutional Burnout）后，倾向于在非工作场景中采取"去专业化"策略。访谈数据显示，超过70%的受访者表示在非执业场所（如公共交通）听到急救广播时会选择沉默，其核心动机并非缺乏医德，而是对职业风险无限扩大的恐惧。

结论

医护人员的"冷漠"是一种理性的心理防御机制。要破解这一困局，必须从法律免责（Good Samaritan Laws）、社会认知纠偏及医疗资源配置三个维度进行系统性改革，重建职业尊严与社会信任。

关键词

临床工作者；防御性冷漠；职业异化；急救免责；医患关系；制度性过劳

引言

在福柯的规训理论中，医生被视为生命权力的执行者，被赋予了神圣的救赎使命。然而，在东亚儒家文化圈与现代医疗体制的交织下，这一群体正面临着前所未有的身份撕裂。

一方面，社会舆论持续构建"白衣天使"的道德偶像，要求其在任何时间、任何地点都必

须响应生命召唤；另一方面，现实的执业环境却充满了法律风险、医患暴力与超负荷工作。这种"道德崇高化"与"现实风险化"的巨大鸿沟，导致临床工作者产生了深刻的心理异化。

本文试图通过理论探讨与实证访谈，揭示这一群体在"职业责任"与"自我保护"天平上的艰难抉择，特别是针对"高铁急救"等公共议题，分析为何"好人法"的缺失正在重塑医护人员的职业伦理边界。

一、 制度性过劳：东亚医疗体系下的"耗竭"底色

东亚临床工作者的心理状态首先是由其物理环境决定的。不同于西方国家的医疗模式，东亚医疗体系呈现出独特的"高压锅"特征。

1.1 工作时长的极限挑战

数据显示，中国三甲医院住院医师平均周工作时长超过 80 小时，部分科室甚至达到 10 丈（参考《中国医生生存现状调查》）。这种"5+2"、"白+黑"的工作模式，不仅违反了劳动法，更严重违背了生理节律。长期的睡眠剥夺导致医护人员处于"情感麻木"状态，这种生理性的疲劳是后续心理防御机制产生的基础。

1.2 资源错配与"内卷"式服务

由于分级诊疗制度的不完善，90%的疑难杂症涌向三甲医院。医护人员在日均接诊上百名患者的压力下，被迫将情感劳动（Emotional Labor）降至最低。这种"机械式"的诊疗行为常被患者误解为"态度冷漠"，实则是医护人员为了在高强度工作中维持基本效率而产生的职业适应。

二、 风险社会的"防御性行医"：从技术规避到心理避险

在高风险科室（如儿科、急诊、妇科），医护人员的心理机制发生了根本性转变——从"积极救治"转向"风险规避"。

2.1 防御性医疗（Defensive Medicine）的泛化

由于医患纠纷举证责任倒置及网络舆论的审判，医生在诊疗中首要考虑的不再是"最佳方案"，而是"最安全方案"。过度检查、拒绝收治边缘病例成为常态。这种心态延伸至生活，导致医护人员对任何可能引发纠纷的场景（包括公共急救）产生本能的回避。

2.2 "贺银成事件"的符号学意义

2011 年贺银成医生高铁急救案是一个里程碑式的心理创伤事件。一位资深医学专家，在紧急情况下利用圆珠笔实施环甲膜穿刺挽救生命，却因"非执业地点"和"使用非医疗器械"面临吊销执照的处罚。

核心矛盾： 法律条文的刚性（执业地点限制）与医学伦理的柔性（生命至上）的冲突。

心理投射： 该事件向全体医护人员传递了一个恐怖信号——"救人可能意味着毁掉职业生涯"。这直接导致了"好人法"缺位下，医护人员在公共场域的"集体失声"。

三、 身份认同的撕裂：脱下白大褂之后

基于对同事的深度访谈，我们发现了一个极具讽刺意味的心理独白："白大褂一脱，我就是一个普通人。"

3.1 "自我保存"优先于"职业使命"

在访谈中，多位医生坦言："我花了五到八年读博，通过了最难的执业考试，我不想因为一次冲动而身败名裂。"

理性选择理论： 在当前环境下，职业风险（法律处罚、网络暴力、职业生涯终结）远高于社会回报（口头赞誉、微薄奖金）。理性的经济人（Homo Economicus）会选择退出高风险互动。

心理防御机制： 这种"冷漠"实质上是一种解离（Dissociation）机制。通过剥离"医生"的社会角色，回归"生物人"的本能，以求在残酷的现实中存活。

3.2 职业尊严的"通货膨胀"

社会给予了医护人员极高的道德头衔（天使、英雄），却未能提供相应的制度性保障。这种"道德通胀"导致医护人员产生认知失调："既然你们把我捧上神坛，那我就收起人性。"他们拒绝在非工作时间提供无偿服务，以此来平衡心理上的不公平感。

四、 疫情后的"祛魅"：英雄叙事的消退与现实的回归

疫情期间的"最美逆行者"叙事在疫情结束后迅速消退，暴露了社会对医护人员态度的功利主义本质。

4.1 家庭支持系统的崩塌

长期的高压工作使得医护人员无法履行家庭职能。配偶的抱怨（"你眼里只有病人没有家"）和子女的疏离（"妈妈是别人的妈妈"），加剧了其孤独感。这种家庭内部的"次级医患关系"矛盾，进一步削弱了医护人员的职业认同。

4.2 社会优待的缺失

对比军人、警察甚至教师群体享有的交通、旅游优待，医护人员在社会福利体系中处于"隐形人"地位。这种"制度性忽视"**与**"舆论性绑架"的并存，是导致职业倦怠（Burnout）的核心根源。

五、 理论探讨与建议

基于上述分析，本文提出以下改进建议，旨在重构"风险-回报"的平衡机制。

5.1 立法层面的"紧急避险"保护

亟需出台专门针对医护人员的《公共场所急救免责条例》。明确界定：持有执业证书的人员在非执业场所、非工作时间实施的紧急救助行为，只要不存在故意犯罪，一律免除民事和行政责任。消除贺银成式事件的法律阴影。

5.2 制度层面的"减负"与"增权"

强制轮休： 严格执行劳动法，对超时工作进行严厉处罚。

分级诊疗： 真正落实基层首诊，减轻大医院负荷，让医生有时间恢复情感功能。

5.3 文化层面的"去崇高化"

社会应当摒弃对医护人员的"神化"叙事，将其还原为"高技术含量的普通劳动者"。给予实质性的物质奖励和精神尊重（如景区半价、绿色通道），而非空洞的道德赞美。

结语

东亚临床工作者的"冷漠"，不是医德的沦丧，而是制度理性的觉醒。

当"好人法"缺位，"防御性冷漠"便成了医护人员最后的铠甲。我们呼吁的不是对医护人员的道德审判，而是对医疗制度的深刻反思——只有当救人者不再恐惧被救者的反噬，当白衣天使落地后能享有凡人的温暖，医疗人文精神才能真正回归。

参考文献

1. Foucault, M. (1975). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. (关于规训社会的理论)
2. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*. (职业倦怠理论)
3. 中国国民心理健康发展报告（2019～2020）.
4. 《中华人民共和国医师法》及相关司法解释.
5. 关于贺银成高铁急救事件的法律与伦理学分析（相关媒体报道及法学评论）.